

TEMA 6.17 • INFECTOLOGÍA

Intoxicación Alimentaria, Diarrea y Microorganismos, Cólera

PERFIL EUNACOM 1.05.1.017  
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

# Intoxicaciones Alimentarias y Diarreas Infecciosas

Intoxicaciones Alimentarias por Agente

| TABLA 6.17.1: AGENTE VS ALIMENTO TÍPICO |                                                     |                       |                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| AGENTE                                  | ALIMENTO TÍPICO                                     | TIEMPO DE LATENCIA    | CLÍNICA PRINCIPAL                                          |
| S. aureus (enterotoxina)                | Cualquier comida manipulada (torta, mayonesa, jugo) | 2-6 horas             | Vómitos intensos. Luego dolor + diarrea.                   |
| Salmonella no-typhi                     | Alimentos de origen animal (huevos, carne, leche)   | 1-3 días              | Diarrea febril                                             |
| Vibrio parahaemolyticus                 | Mariscos (crudos)                                   | 1-2 días              | Diarrea acuosa + vómitos                                   |
| Anisakis (gusano)                       | Pescado crudo (ceviche, sushi)                      | Minutos a pocas horas | Dolor epigástrico + vómitos (gastritis por el parásito)    |
| Marea Roja (dinoflagelados)             | Mariscos (crudos o cocidos)                         | Pocos minutos         | Toxina paralítica → parálisis + insuficiencia respiratoria |
| Tetrodotoxina                           | Pez globo                                           | Minutos               | Parálisis + muerte                                         |

> Notificación inmediata a SEREMI si es intoxicación masiva (brote).  
> Tratamiento: Hidratación + Sintomático (antieméticos, antiespasmódicos). ATB NO se indican de rutina.

Tipos de Diarrea Infecciosa

| TABLA 6.17.2: PATRÓN VS CAUSA MÁS FRECUENTE |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PATRÓN                                      | CAUSA MÁS FRECUENTE                                                                                     |
| Diarrea acuosa aguda                        | Rotavirus (más frecuente), E. coli enterotoxigénica                                                     |
| Diarrea febril                              | E. coli, Salmonella, Yersinia, Campylobacter                                                            |
| Disentería (diarrea con sangre y moco)      | Shigella (causa más frecuente en Chile), E. coli enterohemorrágica (STEC → síndrome hemolítico urémico) |
| Diarrea del viajero                         | E. coli → Tratar con Ciprofloxacino                                                                     |
| Diarrea post-antibiótica                    | Clostridium difficile (1/3 de los casos). Hasta 2 meses post-ATB → buscar C. difficile siempre.         |

Cólera

- **Agente:** *Vibrio cholerae* (bacilo Gram negativo). Erradicado en Chile.
- **Clínica:** Diarrea masiva "en agua de arroz" → deshidratación grave → muerte por hipovolemia.
- **Diagnóstico:** Visualización directa al microscopio o coprocultivo especial.
- **Tratamiento:** Hidratación (VO o EV según gravedad) + **Azitromicina** (de elección). Alternativas: Doxiciclina, Ciprofloxacino.
- Notificación inmediata + vigilancia centinela.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:  
"Grupo de trabajadores consultan en urgencia 3 horas después de almorzar en el casino de la empresa. Todos presentan vómitos intensos y malestar abdominal. ¿Cuál es el agente más probable y la conducta prioritaria?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:  
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Intoxicación Alimentaria, Diarrea y Microorganismos, Cólera. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

- PUNTOS CLAVE DESTACADOS
- Intoxicaciones alimentarias masivas: notificación inmediata. Lo más importante es prevenir nuevos casos.
  - S. aureus: más frecuente, 2-6 horas, vómitos. Salmonella: 1-3 días, origen animal, diarrea febril. V. parahaemolyticus: mariscos crudos. Anisakis: pescado crudo, dolor epigástrico.
  - Marea roja: toxina paralítica de dinoflagelados, mariscos crudos O cocidos. Produce parálisis.
  - Disentería: Shigella es la causa más frecuente en Chile. E. coli enterohemorrágica produce síndrome hemolítico urémico.
  - Diarrea del viajero (E. coli): indicación de ciprofloxacino. Diarrea post-antibiótico: siempre descartar C. difficile (hasta 2 meses post-ATB).
  - Cólera (erradicado): diarrea en agua de arroz, deshidratación severa mortal. Tratamiento: hidratación + azitromicina de elección.
  - Clave diagnóstica: importa el TIEMPO (horas vs días) y el ALIMENTO para identificar el agente de intoxicación alimentaria.

**EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INTOXICACIÓN ALIMENTARIA, DIARREA Y MICROORGANISMOS, CÓLERA)****PREGUNTA 1**

Grupo de trabajadores consultan en urgencia 3 horas después de almorzar en el casino de la empresa. Todos presentan vómitos intensos y malestar abdominal. ¿Cuál es el agente más probable y la conducta prioritaria?

- A)** Salmonella; iniciar ciprofloxacino empírico
- B)** Staphylococcus aureus (enterotoxina); notificación inmediata a SEREMI y tratamiento sintomático
- C)** Vibrio parahaemolyticus; antibióticos endovenosos
- D)** Clostridium difficile; metronidazol oral
- E)** Anisakis; endoscopia digestiva alta

**PREGUNTA 2**

Paciente de 45 años, luego de comer mariscos en la playa, presenta debilidad muscular progresiva e insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Intoxicación por Vibrio parahaemolyticus
- B)** Marea roja (toxina paralítica)
- C)** Botulismo
- D)** Síndrome de Guillain-Barré
- E)** Reacción anafiláctica a mariscos

**PREGUNTA 3**

Paciente con diarrea acuosa muy intensa tipo agua de arroz, deshidratación severa e hipotensión. Antecedente de viaje reciente a zona endémica. ¿Cuál es el tratamiento más importante?

- A)** Azitromicina oral como medida prioritaria
- B)** Hidratación endovenosa con suero fisiológico
- C)** Loperamida para disminuir las deposiciones
- D)** Metronidazol endovenoso
- E)** Ciprofloxacino endovenoso como primera medida

**RESUMEN: INTOXICACIÓN ALIMENTARIA, DIARREA Y MICROORGANISMOS, CÓLERA**

Esta clase aborda las intoxicaciones alimentarias, las diarreas con sus microorganismos y el cólera. Las intoxicaciones alimentarias masivas son de notificación inmediata. El agente más frecuente es Staphylococcus aureus (enterotoxina, 2-6 horas, vómitos predominantes). Las Salmonellas no-typhi aparecen 1-2 días después por alimentos de origen animal con diarrea febril. El Vibrio parahaemolyticus es por mariscos crudos en verano. El anisakis produce vómitos y dolor epigástrico minutos después de comer pescado crudo. La marea roja (toxina paralítica de dinoflagelados) produce parálisis incluso con mariscos cocidos. Respecto a las diarreas: las acuosas son por rotavirus o E. coli enterotoxigénica; las febriles por Salmonella, Yersinia o Campylobacter; las disenterías por E. coli enteroinvasiva/enterohemorrágica (síndrome hemolítico urémico) o Shigella (causa más frecuente en Chile). La diarrea del viajero es por E. coli y se trata con ciprofloxacino. La diarrea post-antibiótico debe descartar Clostridium difficile hasta 2 meses después. El cólera (Vibrio cholerae) fue erradicado en Chile en los años 90. Produce diarrea muy intensa en agua de arroz con deshidratación severa que puede ser mortal. Se vigila con centros centinela. Diagnóstico con observación directa o coprocultivo especial. Tratamiento: hidratación (lo más importante) más azitromicina (de elección), doxiciclina o ciprofloxacino.